

健康体检报告

ISO
9001

健康成就
更多可能

ISO
27001

ISO
15189

揭桂连 女士 56岁

证件号码: 360*****6126

联系电话: 188*****5587

部 门:

员 工 号:

单位名称: 奥克兰

体检套餐: 26奥克兰-A套餐-女已婚

体检机构: 慈铭健康体检管理集团有限公司北京亮马桥医院

报告方式: 给健管顾问

检查日期: 2026-03-01

健康顾问: 丁俊



71055732653897

慈铭健康体检管理集团有限公司北京亮马桥医院

咨询电话: 01084535277



报告查询



微信公众号

I 健康体检报告导读

尊敬的 揭桂连 女士

您好!

衷心感谢您选择慈铭健康体检管理集团有限公司北京亮马桥医院为您提供健康体检服务,我们深感荣幸!现将您的健康体检报告呈上,敬请阅读。

您的健康体检报告主要包括以下六个部分:

第一部分 健康体检问卷。健康体检问卷是您健康体检报告的重要组成部分,它包括您健康状况的诸多方面,是分析您健康状态的重要基础信息。

第二部分 健康警示灯。将您本次体检的部分阳性结果,在人体结构图的相应部位进行健康预警标识,便于您更直观、更快捷地了解阳性结果的情况。

第三部分 主检报告。初审医师对您体检中发现的异常结果进行汇总分析,并初步提出医学建议。主检专家全面审核各科室报告及初审医师报告,对疑难问题进行专家会诊,确保内容的准确性、权威性,最终由主检专家签发您的健康体检报告。

第四部分 历次体检数据对比。综合分析您历次体检结果,为您提供《近三年关键指标对比》和《近两次体检实验室检查数据对比》,并与慈铭健康体检数据库进行匹配,展示您所在年龄段区间的大数据分析结果,连续地、动态地观察分析健康指标的变化轨迹和发展趋势,为健康管理提供依据。

第五部分 医学科普。针对本次体检中发现的异常结果进行医学知识科普。

第六部分 分项检查结果及图文报告。汇总各科室检查结果明细,便于您了解各个体检项目的具体情况,可作为您专科诊断或复查的参考资料。同时附有相关科室检查图文报告,如心电图、超声、DR、CT、MRI、骨密度、经颅多普勒报告等。

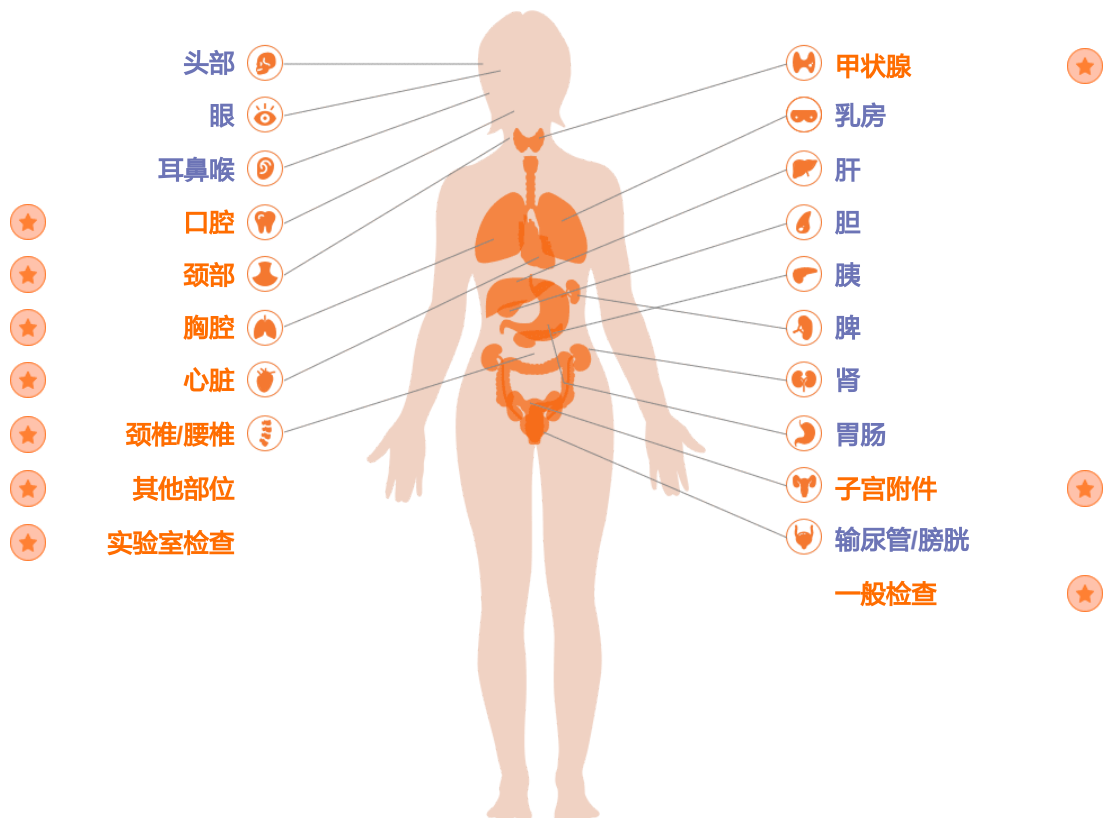


I 健康体检问卷

您本次未提供健康问卷，健康问卷是体检报告的重要组成部分，可对您的健康进行风险评估，望您下次体检时，能在工作人员引导下填写健康问卷，谢谢！

I 健康警示灯

- 将您本次体检的部分异常结果，在人体结构图的相应部位进行健康预警标识，便于您更直观、更快捷地了解异常结果的情况。



I 主检报告

初审医师: 张俊男

终审医师: 许莲芳

主要健康问题:

医师建议:

1、甲状腺彩超:甲状腺右叶海绵样结节 (TI-RADS 3类)

是甲状腺细胞在局部异常生长所致, 多系甲状腺良性疾病的表现, 少数可为恶性结节。TI-RADS 3类提示良性结节可能, 恶性风险 $\leq 5\%$; 建议3~6个月复查甲状腺B超, 甲状腺专科随诊。

一般健康问题:

医师建议:

1、血脂异常

低密度脂蛋白胆固醇测定增高:4.63mmol/L(参考区间:1.89-4.21)
血清总胆固醇测定增高:7.37mmol/L(参考区间:3-5.7)

多与饮食结构不合理和运动量不足有关, 部分有遗传倾向, 易导致糖尿病和动脉粥样硬化性心血管疾病。建议低脂低糖膳食, 多食新鲜蔬菜和水果, 少食动物脂肪和油炸食物, 适量增加有氧运动, 心血管内科或内分泌科调脂治疗。

2、常规心电图检查 (12导联):ST-T改变

常见于冠状动脉供血不足导致的心肌缺血, 也可见于非特异性改变和电解质紊乱。建议结合既往史做运动负荷心电图和冠脉CT检查, 如有心悸、胸闷、胸痛等症状请及时心血管内科就诊。

3、胸部CT平扫:左肺实性结节灶

多与肺部炎症或陈旧性病变等因素有关, 但应在一段时间内关注大小和形态变化, 以排除恶性结节。建议6个月时复查胸部CT, 如结节明显增大或有异常征象时请及时呼吸科或胸外科诊治。

4、血压:高血压1级可能:(141/93mmHg)

本次测量血压偏高。建议您不要吸烟和饮酒, 低脂低盐饮食, 适量运动; 在诊室非同日3次测量血压, 或在家庭连续5~7天测量血压, 如诊室血压均 $\geq 140/90$ mmHg, 或家庭血压平均值 $\geq 135/85$ mmHg, 请心血管内科就诊。

5、胸部CT平扫:左肺内钙化灶
胸部CT平扫:肺内纤维灶

多为局部组织炎症或损伤愈合机化过程中纤维化和钙盐沉积所致, 一般无需治疗, 建议您每年复查胸部CT, 呼吸科随诊。

6、心脏彩超:三尖瓣少量反流
心脏彩超:二尖瓣少量反流
心脏彩超:室间隔增厚
心脏彩超:左室舒张功能减低

心脏瓣膜轻度反流多为功能性改变, 部分与心脏疾病相关。左心室舒张功能减低可能与瓣膜反流和心脏退行改变有关。建议每年复查心脏超声, 若有心悸、气短、胸痛等症状时请心血管内科就诊。

7、常规心电图检查 (12导联):短P-R间期

短P-R间期大多数无临床症状, 少数易发反复的心动过速。建议定期复查心电图。若出现胸闷、心悸、心跳过快等情况, 请及时心血管内科就诊。

8、动脉粥样硬化 颈动脉彩超:右侧颈总动脉斑块形成(多发) 颈动脉彩超:左侧颈总动脉内-中膜增厚 胸部CT平扫:主动脉局部管壁钙化	与年龄因素、高血压、糖尿病和脂质代谢异常有关,是动脉粥样硬化的特征性病变。多为脂质在动脉血管壁沉积所致,是冠心病、脑梗死及外周血管病的主要原因。建议低脂饮食,多吃蔬菜、水果、谷物和豆类食品;不要吸烟和饮酒,适量运动;定期检查血脂血糖,积极控制相关危险因素,心血管科/神经内科随诊。
9、体重指数:超重(体重指数 25.7 kg/m²)	热量摄入多于消耗所致,多与生活方式不当相关。建议控制膳食总量,低脂、低糖饮食,同时增加新鲜蔬菜和水果在膳食中的比重,逐渐增加规律的有氧运动,控制体重增长。
10、白带清洁度异常:III	建议您保持健康的生活方式和良好的卫生习惯,如有不适症状请妇科就诊。
11、附件彩超(经腹部):双侧附件显示不清	可由卵巢萎缩、卵巢位置变异、肠道及其内容物干扰等因素所致。建议结合既往史,必要时2周左右复查盆腔超声或CT,避免遗漏重要阳性。
12、颈椎侧位DR:颈椎退行性改变	主要与年龄、劳损、外伤、姿势不正确等因素有关,易引起颈项部疼痛和功能障碍。请注意矫正姿势,保持正确的站姿和坐姿,颈部同一姿势不应保持太久,症状明显或严重影响活动时骨科或康复科检查治疗。
13、胃泌素17增高:7.17pmol/L(参考区间:1-7) 胃蛋白酶原I增高:184.99ug/L(参考区间:70-165) 胃蛋白酶原II增高:23.71ug/L(参考区间:3-11)	可见于胃窦炎症、糜烂和溃疡等疾病,胃泌素-17异常升高增加胃恶性肿瘤风险。建议年度做胃镜检查 and C13或C14呼气试验,消化科随诊。
14、嗜酸性粒细胞百分数减低:0.3%(参考区间:0.4-8) 大血小板比率减低:0.1fL(参考区间:0.15-0.48) 红细胞比容测定增高:46.8%(参考区间:35-45) 血小板分布宽度减低:8.4fL(参考区间:9.8-18.2) 血红蛋白测定增高:156.00g/L(参考区间:115-150)	建议您结合病史和症状定期复查血常规,如有明显异常请内科就诊。
15、尿隐血弱阳性	建议结合病史和症状,充分休息后留中段尿复查,如持续异常时请肾内科就诊。
16、高密度脂蛋白胆固醇测定增高:1.82mmol/L(参考区间:1.03-1.55)	有利于延缓动脉粥样硬化形成,降低动脉粥样硬化性心血管疾病风险。

17、口腔多项异常

缺齿:牙体缺损

龋齿:部分牙楔状缺损

口腔多种疾病可使咀嚼功能降低而导致消化不良，并可对全身健康造成影响。建议保持良好的口腔健康观念和自我口腔保健意识；口腔科就诊，根据不同病变的各自特点采取相应的治疗措施。

18、既往史:结扎术后（既往史）

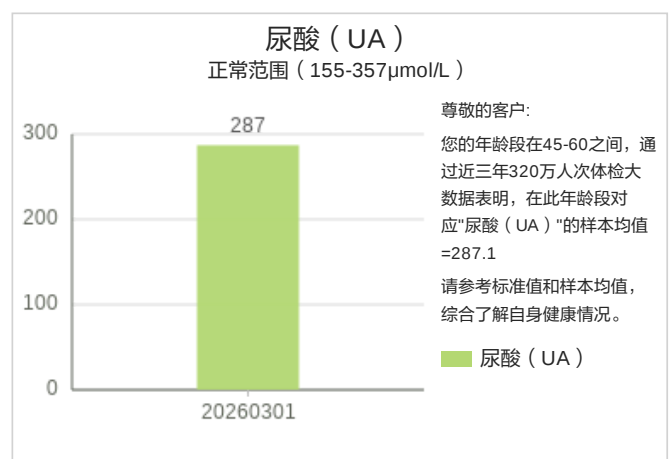
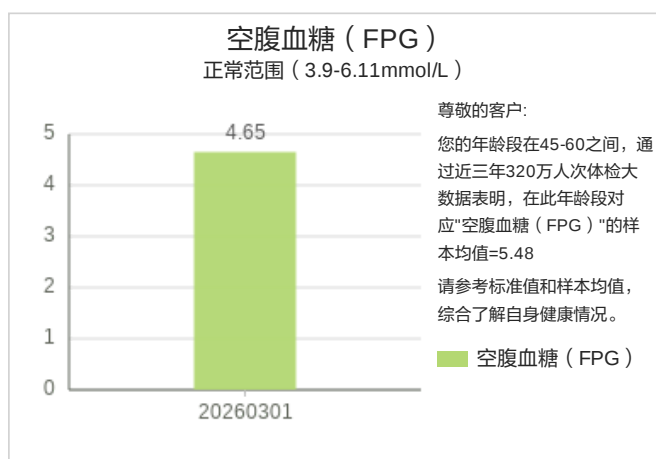
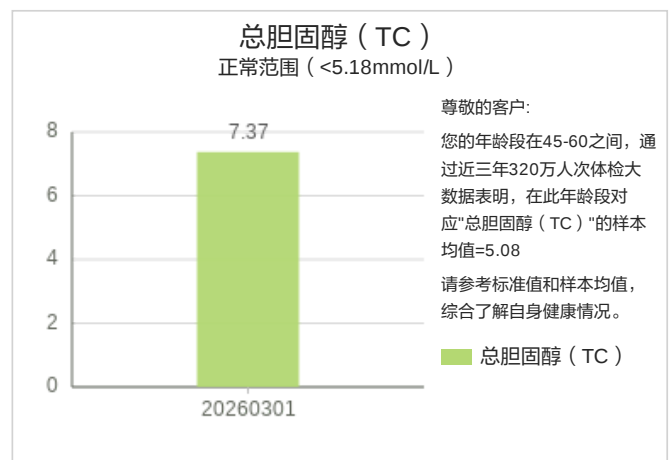
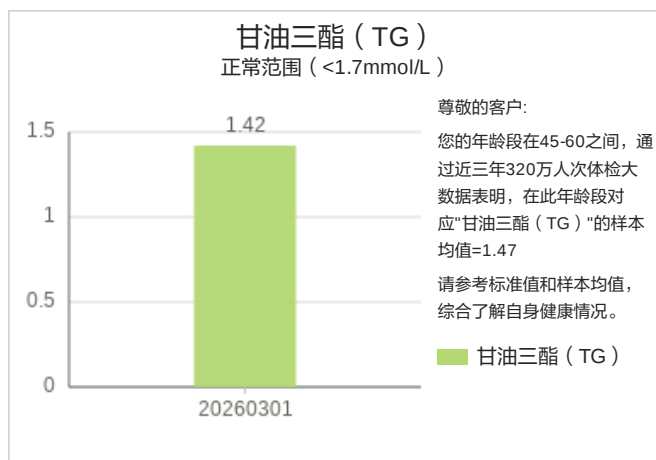
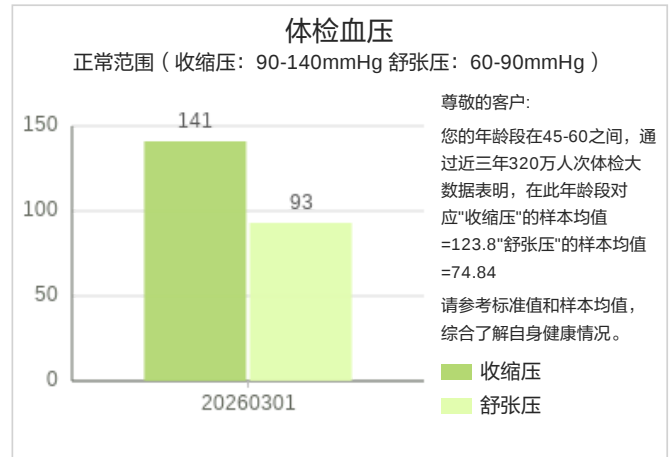
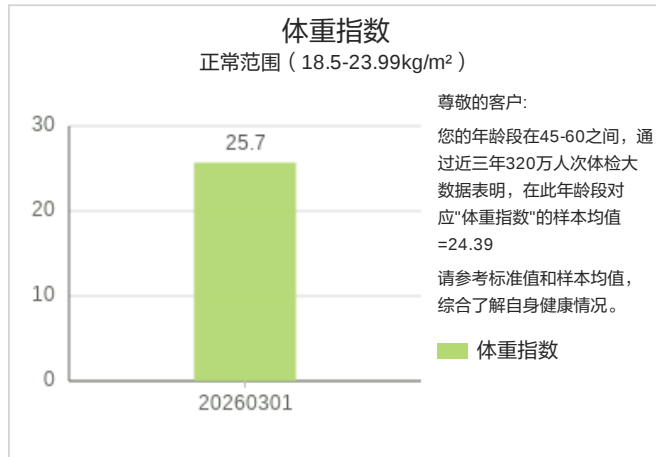
请遵术后医嘱随诊。

历年体检数据对比

三年关键指标对比

历年体检结果对比能够直观判断您原有体检各指标几年内的发展趋势，对健康指标进行连续、动态的观察，有助于全面了解自身健康状况，并为相关医疗及健康管理建议干预评价提供数据依据。

慈铭历年对比的样本数据为慈铭体检连续三年的体检数据，样本量约320万人次。在模型归类当中，数据样本计算出18岁至30岁、30岁至45岁、45岁至60岁、60岁至75岁、75岁以上，五个年龄段男、女分别指标样本的平均参考值，用于和对应平均参考值个体结果的对比，使对比和临床更加立体，完善健康教育，达到预防为主的健康目的。



I 医学科普

【甲状腺右叶海绵样结节（TI-RADS 3类）】

是甲状腺细胞在局部异常生长所致，多系甲状腺良性疾病的表現，少数可为恶性结节。

【血脂异常】

低密度脂蛋白胆固醇测定结果为4.63mmol/L（参考区间：1.89-4.21），属于增高范围。低密度脂蛋白胆固醇是一种将胆固醇运载至外周组织细胞的脂蛋白颗粒，可被氧化为氧化低密度脂蛋白。当低密度脂蛋白，尤其是氧化修饰的低密度脂蛋白过量时，其携带的胆固醇会沉积在动脉壁上，导致动脉硬化。因此，低密度脂蛋白胆固醇被称为“坏胆固醇”，其血清水平增高是冠心病的直接危险因素。血清总胆固醇测定结果为7.37mmol/L（参考区间：3-5.7），同样属于增高范围。血清总胆固醇（TC）是指各种脂蛋白所含胆固醇的总和，来源于食物和肝脏合成。胆固醇是生成肾上腺皮质激素、胆汁酸及维生素D等生理活性物质的重要原料，也是构成细胞膜的主要成分。影响胆固醇水平的因素包括：1、年龄与性别：中青年女性低于男性，女性绝经后较同年男性高。2、长期进食高胆固醇、高饱和脂肪和高热量饮食，可使胆固醇增高。3、遗传因素。4、其他因素，如缺少运动、脑力劳动、精神紧张等可能使TC升高。高胆固醇血症是冠心病的主要危险因素之一。

【ST-T改变】

ST段超过正常范围的下移或抬高。T波在以R波为主的导联中形态和振幅的改变。常见于心肌缺血，电解质紊乱等。亦可见于部分年轻人尤其是年轻和更年期的妇女以及心动过速者的心电图。可出现ST-T非特异性功能性改变，应与心肌炎、冠心病区分开来。心率较快者也可通过口服心得安试验加以鉴别。

【左肺实性结节灶】

肺结节为影像学上发现的肺内局灶性、圆形、类圆形、密度增高影。肺结节包括炎性结节、错构瘤、结核球、真菌感染、硬化性肺细胞瘤及肺癌、转移瘤等。

【高血压1级可能:(141/93mmHg)】

高血压是以体循环动脉压增高为主要表现的临床综合征。分为原发性高血压和继发性高血压。高血压分3级：（1）1级高血压（轻度）：收缩压140-159mmHg和（或）舒张压90-99mmHg；（2）2级高血压（中度）：收缩压160-179mmHg和（或）舒张压100-109mmHg；（3）3级高血压（重度）：收缩压≥180mmHg和（或）舒张压≥110mmHg。

【左肺内钙化灶】

肺钙化灶多为局部组织炎症或损伤愈合机化过程中纤维化和钙盐沉积所致，一般无需治疗。

【肺内纤维灶】

肺内纤维灶一般提示肺内有陈旧性的病变，通常是由于肺部感染愈合以后留下的疤痕病灶。

【三尖瓣少量反流】

心脏瓣膜轻度反流多为功能性改变，部分与心脏疾病相关。

【二尖瓣少量反流】

心脏瓣膜轻度反流多为功能性改变，部分与心脏疾病相关。

【室间隔增厚】

心肌肥厚是产生较缓慢但较有效的代偿功能，主要发生在长期压力负荷过重的情况下，使心脏得以维持正常的血液循环。但肥大的心肌需氧增加，而冠状动脉的供血量往往不能予以满足，造成心肌缺血，最后易导致心肌收缩力的减退。

【左室舒张功能减低】

可能与心脏疾病的早期改变或心脏退行性变有关。

【短P-R间期】

呈现短的P-R间期（ <0.12 秒）和无 δ 波的正常QRS图形心电图表现。可伴有阵发性室上性心动过速或心房扑动、心房颤动伴以快速的心室率，故称为短P-R综合征。短P-R综合征是存在房室结旁路所致，是预激综合征的变异型，也称L-G-L综合征。大多数短P-R综合征患者无器质性心脏病，可无任何症状。少数患者见于窦房结病变、二尖瓣疾患、二尖瓣脱垂及心肌病等。如少数伴有心律失常的短P-R综合征患者，可出现心悸、胸闷、气短、头晕、晕厥等症状，也可合并阵发性室上性心动过速。

【动脉粥样硬化】

右侧颈总动脉斑块形成（多发）及左侧颈总动脉内-中膜增厚均为动脉粥样硬化的表现，前者为脂质在动脉血管壁沉积所致，是冠心病、脑梗死及外周血管病的主要原因，后者为动脉粥样硬化的早期改变，与动脉粥样硬化性心血管疾病密切相关。主动脉局部管壁钙化是动脉粥样硬化的特征性病变，与年龄因素、高血压、糖尿病和脂质代谢异常有关，是发生心脑血管疾病的危险因素。

【超重(体重指数 25.7 kg/m^2)】

中国标准：体重指数（BMI） $24.0-27.9 \text{ kg/m}^2$ 为体重超重，超重容易引起多种疾病，比如高血压、糖尿病、高血脂、动脉粥样硬化等。所以对超重应当限制饮食摄入，并增加运动量，使摄入的总热量，低于消耗的总热量，以控制体重。

【白带清洁度异常:III】

正常阴道分泌物为白色稀糊状液体、无气味、量多少不等，其性状与生殖器充血情况及雌激素水平有关，不同颜色和性状的阴道分泌物临床意义不同。III度提示炎症，如阴道炎、宫颈炎。IV度多见于严重阴道炎，如滴虫性阴道炎、真菌性阴道炎等。

【双侧附件显示不清】

附件彩超显示一侧附件显示不清，可能与肠道气体干扰、膀胱充盈不足或解剖位置遮挡有关。此类情况通常无明显症状，但可能影响对附件区病变的判断。建议保持膀胱适度充盈后复查，或选择经阴道超声进一步评估。若无其他异常表现，一般不影响日常生活。

【颈椎退行性改变】

颈椎退行性变是指颈椎自然老化、退化的生理病理过程，引起颈部疼痛和神经功能障碍。多见于中老年人，与年龄、内分泌失调、长期伏案工作、姿势、体位不当等因素有关，症状随年龄增加而逐渐加重。

【胃泌素17增高:7.17pmol/L(参考区间:1-7)】

血清胃泌素17含量是反应胃窦分泌功能的敏感指标，在诊断和筛查萎缩性胃炎和胃泌素瘤方面有重要意义，是早期胃癌筛查的一项指标。胃泌素-17检查增高可能存在某些胃部疾病，例如胃炎，胃窦炎，胃泌素瘤、胃窦黏膜过度增生、胃部肿瘤。

【胃蛋白酶原I增高:184.99ug/L(参考区间:70-165)】

胃蛋白酶原(PG)是胃蛋白酶的前体，无酶活性。胃蛋白酶原(PG)分为两个亚群：PGI，PGII。PGI来源于胃底腺的主细胞和颈黏液细胞，PGII则来源于全胃腺和近端十二指肠。胃黏膜细胞合成后的PG大部分进入胃腔，在酸性胃液作用下活化成具有活性的胃蛋白酶来帮助消化，少量PG进入血液循环，当胃黏膜发生病理变化时，血清PG含量也随之发生改变。胃溃疡和十二指肠溃疡患者的PGI和PGII明显升高，PGI/II比值也升高，治疗后下降，复发时又升高。胃蛋白酶原I和胃蛋白酶原II同时增高多见于胃部炎症。

【胃蛋白酶原II增高:23.71ug/L(参考区间:3-11)】

胃蛋白酶原(PG)是胃蛋白酶的前体，无酶活性。胃蛋白酶原按其免疫原性不同可将胃蛋白酶原分为两个亚群：PGI，PGII。PGI来源于胃底腺的主细胞和颈黏液细胞，PGII则来源于全胃腺和近端十二指肠。胃黏膜细胞合成后的PG大部分进入胃腔，在酸性胃液作用下活化成具有活性的胃蛋白酶来帮助消化，仅有少量PG进入血液循环，当胃黏膜发生病理变化时，血清PG含量也随之发生改变。单独胃蛋白酶原II增高无确切临床意义，如伴有胃蛋白酶原I增高，多见于胃部炎症。

【嗜酸性粒细胞百分数减低:0.3%(参考区间:0.4-8)】

嗜酸性粒细胞是粒细胞胞质中含有特殊颗粒。降低常见于伤寒，副伤寒的初期以及大手术，烧伤，劳动，寒冷，饥饿，精神刺激等应激状态等。

【大血小板比率减低:0.1fL(参考区间:0.15-0.48)】

大血小板比率是指大血小板占有血小板总数的比例。大血小板比率减低常见于骨髓造血功能衰竭、恶性肿瘤接受放化疗治疗等。

【红细胞比容测定增高:46.8%(参考区间:35-45)】

增高常见于各种原因所致的血液浓缩。

【血红蛋白测定增高:156.00g/L(参考区间:115-150)】

血红蛋白增多指单位容积血液中血红蛋白量高于参考值高限。常见于严重呕吐、腹泻、大量出汗、大面积烧伤、慢性肾上腺皮质功能减退、尿崩症、甲状腺功能亢进危象、糖尿病酮症酸中毒、真性红细胞增多症等。

【尿隐血弱阳性】

尿隐血阳性：见于泌尿系结石、急性肾小球肾炎、慢性肾炎、泌尿系肿瘤、结核、肾盂肾炎、膀胱炎、狼疮性肾炎、紫癜性肾炎等疾病，剧烈运动、重体力劳动、久站之后也可能导致尿隐血阳性。

【高密度脂蛋白胆固醇测定增高:1.82mmol/L(参考区间:1.03-1.55)】

高密度脂蛋白胆固醇是具有抗动脉粥样硬化的脂蛋白，所以称为“好胆固醇”，高密度脂蛋白胆固醇升高提示其抗动脉硬化的作用更充分。

【 口腔多项异常 】

牙体缺损是指由于各种原因引起的牙体硬组织不同程度的外形和结构的破坏和异常，表现为牙体失去了正常的生理解剖外形，造成正常牙体形态、咬合及邻接关系的破坏。部分牙楔状缺损多因为不良刷牙方法、唾液酸性环境的作用、牙颈部结构薄弱以及咬合应力集中，共同导致牙颈部实质缺损。

【 结扎术后（既往史） 】

为避孕的一种措施。

I 分项报告

【一般检查】

项目	结果	单位	参考范围
身高	158	cm	-
体重	64.2	kg	-
体重指数	25.7	kg/m ²	18.5~23.9
理想体重	51.2	kg	-
收缩压	141	mmHg	90-139
舒张压	93	mmHg	60-89
脉搏	71	次/分	60~100
收缩压（复测第1次）	自愿弃查	mmHg	90-139
舒张压（复测第1次）	自愿弃查	mmHg	60-89
收缩压（复测第2次）	-	mmHg	90-139
舒张压（复测第2次）	-	mmHg	60-89
小结	体重指数:超重(25.7 kg/m ²) 血压:高血压1级可能(141/93 mmHg)		

操作者: 张怡冉

【内科】

项目	结果	单位	参考范围
既往史	无	-	-
家族史	无	-	-
胸廓	未见明显异常	-	-
心脏-心率	72	次/分	60~100
心脏-杂音	未闻及	-	-
心脏-心律	未闻及明显异常	-	-
心脏-心音	未闻及明显异常	-	-
心脏-心界	未见明显异常	-	-
肺-呼吸频率	16	次/分	12~20
肺-啰音	未闻及	-	-

肺-呼吸音	未闻及明显异常	-	-
肺-胸膜摩擦音	未闻及	-	-
肝-大小	未触及	-	-
肝-质地	未触及明显异常	-	-
肝-压痛	无压痛	-	-
胆-大小	未触及	-	-
胆-压痛	无压痛	-	-
脾-大小	未触及	-	-
脾-质地	未触及明显异常	-	-
脾-压痛	无压痛	-	-
肾-叩击痛	无叩击痛	-	-
腹壁	未见明显异常	-	-
膝反射	未见明显异常	-	-
其他	未见明显异常	-	-
小结	未见明显异常		

医师: 张薇

【外科】

项目	结果
既往史	无
皮肤	未见明显异常
浅表淋巴结	未触及明显异常
甲状腺	未见明显异常
乳房	未见明显异常
脊柱	未见明显异常
四肢关节	未见明显异常
其他	未见明显异常
小结	未见明显异常

医师: 肖华

【妇科】

项目	结果
既往史	结扎术
月经史与生育史	阴道分娩2次；绝经年龄55岁
外阴	未见明显异常
阴道	未见明显异常
宫颈	未见明显异常
子宫	未见明显异常
附件	未见明显异常
其他	未见明显异常
小结	既往史:结扎术后（既往史）

医师: 罗天霞

【口腔科】

项目	结果
既往史	无
口腔黏膜	未见明显异常
牙龈	未见明显异常
牙周	未见明显异常
龋齿	5A(右上第5牙)、4A(右上第4牙)、3A(右上第3牙)部分牙楔状缺损
缺齿	5C(右下第5牙)牙体缺损
牙齿松动	无
义齿	无
颞下颌关节	未见明显异常
腮腺	未见明显异常
舌	未见明显异常
其他	未见明显异常
小结	龋齿:部分牙楔状缺损 缺齿:牙体缺损

医师: 吴蓉

【心电图】

项目	结果
----	----

常规心电图检查（12导联）
窦性心律 HR (67)次/分
短P-R间期
ST-T改变（V1-V5）
建议：请结合临床，进一步专科诊治。

小结
常规心电图检查（12导联）：窦性心律
短P-R间期
ST-T改变

注：详见图文报告。

操作者：疏芳

报告医师：



【肝胆脾胰双肾彩超】

项目	结果
肝脏彩超	肝脏形态大小正常，轮廓规整，实质回声均匀，肝内管道结构清晰。门静脉未见扩张。
胆囊彩超	胆囊形态大小正常，壁光滑，内未见明显异常回声。胆总管不扩张。
脾脏彩超	脾脏形态正常，包膜光整，实质回声均匀。
胰腺彩超	胰腺形态大小正常，轮廓规整，实质回声均匀，主胰管不扩张。
双肾彩超	双肾形态大小正常，包膜光整，实质回声均匀。集合系统未见分离。
小结	肝脏彩超:肝脏声像图未见明显异常 胆囊彩超:胆囊声像图未见明显异常 脾脏彩超:脾脏声像图未见明显异常 胰腺彩超:胰腺声像图未见明显异常 双肾彩超:双肾声像图未见明显异常

注：详见图文报告。

医师：邢淑华

【甲状腺彩超】

项目	结果
甲状腺彩超	甲状腺双叶及峡部形态大小正常，甲状腺右叶可见一个海绵样结节，大小约为14.9mm×13.5mm×7.3mm，边缘清楚，后方回声增强；CDFI：结节内未见明显血流信号。甲状腺左叶及峡部未见明显异常。
小结	甲状腺彩超:甲状腺右叶海绵样结节（TI-RADS 3类）

注：详见图文报告。

医师：邢淑华

【妇科彩超（经腹部）】

项目	结果
----	----

子宫彩超(经腹部)	子宫体积缩小，轮廓光整，肌层回声欠均匀，内膜厚约4.2mm，宫腔线居中。宫颈未见明显异常。
附件彩超(经腹部)	双侧附件显示不清。
小结	子宫彩超(经腹部):绝经期子宫 附件彩超(经腹部):双侧附件显示不清
注：详见图文报告。	
医师：邢淑华	

【乳腺超声】	
项目	结果
乳腺超声	双侧乳腺腺体层次结构清晰，内部回声分布均匀，未见明显异常包块回声，CDFI：腺体内未见明显异常血流信号。
小结	乳腺超声:双侧乳腺未见明显异常
注：详见图文报告。	
医师：邢淑华	

【颈动脉彩超】	
项目	结果
颈动脉彩超	双侧颈总动脉、颈内动脉、颈外动脉管径对称，走行正常，内膜光滑，左侧内中膜不均匀增厚，较厚处约1.1mm，未见明显斑块回声，动脉管腔未见异常扩张或狭窄。PW：见双侧颈动脉血流速度及阻力指数在正常范围。右侧颈总动脉管壁可见多个高回声斑块，大者约4.1mm×2.9mm；CDFI：斑块处血流充盈缺损；血流速度及频谱形态大致正常。
小结	颈动脉彩超:左侧颈总动脉内-中膜增厚 右侧颈总动脉斑块形成（多发）
注：详见图文报告。	
医师：邢淑华	

【心脏彩超】	
项目	结果
心脏彩超	1、各房室腔内径正常范围。主动脉及肺动脉内径及运动幅度正常。室间隔增厚，较厚处约13.1mm。左室壁厚度、运动幅度正常。房室间隔连续性完整。2、各瓣膜形态、启闭未见异常。CDFI：收缩期二尖瓣可见少量反流信号，收缩期三尖瓣可见少量反流信号，余各瓣口流速正常。3、心包结构正常。4、左室收缩功能参数正常。二尖瓣口前向血流：PW：E峰<A峰。TDI测得二尖瓣后瓣运动频谱e峰<a峰。心功能测值：EF：66% FS：34%。

小结

心脏彩超:室间隔增厚

二尖瓣少量反流

三尖瓣少量反流

左室舒张功能减低

注: 详见图文报告。

医师: 邢淑华

【头颅CT平扫】

项目	结果
头颅CT平扫	两侧脑实质内未见明显异常密度影及占位征象, 诸脑室、脑池系统未见明显异常。诸脑沟未见明显异常扩大及变窄。中线结构居中。所示颅骨及软组织内未见明显异常。
小结	头颅CT平扫:头颅CT平扫未见明显异常

注: 详见图文报告。

报告医师: 张新华

审核医师: 何维龙

【胸部低剂量螺旋CT】

项目	结果
胸部CT平扫	两侧胸廓对称; 双侧肺门不大; 心影及大血管形态正常。主动脉局部管壁可见钙化斑块影。纵隔未见肿大淋巴结。双肺野支气管血管束清晰, 走行自然。左肺下叶见多发实性结节, 较大者位于左肺下叶前内基底段 (Se7: IM216), 大小约为5mm×4mm。左肺下叶前内基底段 (Se7: IM159) 见钙化结节, 大小约为3mm×2mm。双肺散在纤维条索影。
小结	胸部CT平扫:左肺实性结节灶, 建议复查 左肺内钙化灶 肺内纤维灶 主动脉局部管壁钙化

注: 详见图文报告。

报告医师: 张新华

审核医师: 何维龙

【颈椎侧位DR(不出片)】

项目	结果
颈椎侧位DR	颈椎生理曲度存在, 排列尚整齐, 未见明显脱位征象。颈4-7椎体边缘可见骨质增生, 椎体未见明显骨质破坏。颈4-7椎间隙变窄。前纵韧带钙化。
小结	颈椎侧位DR:颈椎退行性改变

注: 详见图文报告。

报告医师: 文豪杰

审核医师: 李宇川

带★项目为京津冀鲁互认项目

【血常规】

检测机构: 慈铭健康体检管理集团有限公司 样本类型: 全血
司北京亮马桥医院
采集时间: 2026-03-01 08:25:03 检测时间: 2026-03-01 09:08:54 报告时间: 2026-03-01 09:41:23
【备注: 无】

项目	简称	结果	提示	单位	参考区间
★ 白细胞计数	WBC	6.31	-	10 ⁹ /L	3.5--9.5
中性粒细胞百分数	GRAN%	71.5	-	%	40-75
淋巴细胞百分数	LYM%	21.20	-	%	20--50
单核细胞百分数	Mono%	7.00	-	%	3--10
嗜酸性粒细胞百分数	Eos%	0.3	↓	%	0.4-8
嗜碱性粒细胞百分数	Baso%	0.000	-	%	≤1
中性粒细胞绝对值	GRAN#	4.51	-	10 ⁹ /L	1.8-6.3
淋巴细胞绝对值	LYM#	1.34	-	10 ⁹ /L	1.1--3.2
单核细胞绝对值	Mono#	0.44	-	10 ⁹ /L	0.1-0.6
嗜酸性粒细胞绝对值	Eos#	0.02	-	10 ⁹ /L	0.02-0.52
嗜碱性粒细胞绝对值	Baso#	0.000	-	10 ⁹ /L	≤0.06
★ 红细胞计数	RBC	5.08	-	10 ¹² /L	3.8--5.1
★ 血红蛋白	Hb	156.00	↑	g/L	115-150
★ 红细胞比容	HCT	46.8	↑	%	35-45
★ 红细胞平均体积	MCV	92.1	-	fL	82-100
★ 平均血红蛋白含量	MCH	30.70	-	pg	27-34
★ 平均血红蛋白浓度	MCHC	333.00	-	g/L	316-354
红细胞分布宽度-标准差	RDW-SD	44.30	-	fL	35-60
红细胞分布宽度-变异系数	RDW-CV	13.4	-	%	11-15.5
★ 血小板计数	PLT	302.00	-	10 ⁹ /L	125-350
平均血小板体积	MPV	8.0	-	fL	8-15
血小板压积	PCT	0.0024	-	fL	0.0011-0.0028
血小板分布宽度	PDW	8.4	↓	fL	9.8-18.2
大血小板比率	P-LCR	0.1	↓	fL	0.15-0.48

注: 本检测结果仅对来样负责, 供临床参考。如有疑问请在样品保存期内提出!

检验者: 李建华

审核者: 刘欣悦

带★项目为京津冀鲁互认项目

【尿常规】

检测机构: 慈铭健康体检管理集团有限公司 样本类型: 尿液 样本性状: 样本正常
司北京亮马桥医院
采集时间: 2026-03-01 10:12:44 检测时间: 2026-03-01 10:48:04 报告时间: 2026-03-01 10:52:13
【备注: 无】

项目	简称	结果	提示	单位	参考区间
★ 尿白细胞酯酶	LEU	阴性	-	-	阴性
★ 尿酮体	KET	阴性	-	-	阴性
★ 尿亚硝酸盐	NIT	阴性	-	-	阴性
★ 尿胆原	URO	阴性	-	-	阴性或弱阳性
★ 尿胆红素	BIL	阴性	-	-	阴性
★ 尿蛋白质	PRO	阴性	-	-	阴性
★ 尿葡萄糖	GLU	阴性	-	-	阴性
★ 尿比重	SG	1.015	-	-	1.004-1.03
★ 尿隐血	BLD	弱阳性	↑	-	阴性
★ 尿酸碱度	pH	6.50	-	-	4.5-8
尿白细胞（镜检）	U-WBC	未见	-	个/HP	≤3
尿红细胞（镜检）	U-RBC	未见	-	个/HP	≤3
尿结晶（镜检）	U-CRYSTAL	未见	-	个/LP	未见
尿管型（镜检）	U-CAST	未见	-	个/HP	未见
尿上皮细胞（镜检）	EC	未见	-	-	少见

注：本检测结果仅对来样负责，供临床参考。如有疑问请在样品保存期内提出！
检验者: 刘欣逸 审核者: 李建华

【白带常规】

检测机构: 慈铭健康体检管理集团有限公司 样本类型: 分泌物 样本性状: 样本正常
司北京亮马桥医院
采集时间: 2026-03-01 08:32:14 检测时间: 2026-03-01 09:05:55 报告时间: 2026-03-01 09:09:28
【备注: 无】

项目	简称	结果	提示	单位	参考区间
白带清洁度	VC	III	+	°	I-II
真菌	Fungus	阴性	-	-	未检出
滴虫	TV	阴性	-	-	未检出

注：本检测结果仅对来样负责，供临床参考。如有疑问请在样品保存期内提出！
检验者: 刘欣逸 审核者: 李建华

带★项目为京津冀鲁互认项目

【生化检测】

检测机构: 慈铭健康体检管理集团有限公司 样本类型: 血清 样本性状: 样本正常
司北京奥亚医院
采集时间: 2026-03-01 08:25:03 检测时间: 2026-03-01 13:26:50 报告时间: 2026-03-01 14:16:11
【备注: 无】

项目	简称	结果	提示	单位	参考区间
★ 血清丙氨酸氨基转移酶	ALT	21	-	U/L	7--40
★ 血清天门冬氨酸氨基转移酶	AST	19	-	U/L	13--35
★ 血清γ-谷氨酰基转移酶	GGT	19	-	U/L	7-45
★ 血清碱性磷酸酶	ALP	71	-	U/L	50-135
动脉粥样硬化指数(计算值)	AI	3.05	-	-	0-3.99
★ 血清总胆固醇	TC	7.37	↑	mmol/L	3-5.7
★ 血清甘油三酯	TG	1.42	-	mmol/L	<1.7
★ 血清高密度脂蛋白胆固醇	HDL-C	1.82	↑	mmol/L	1.03-1.55
★ 血清低密度脂蛋白胆固醇	LDL-C	4.63	↑	mmol/L	1.89-4.21
★ 血清肌酸激酶	CK	77	-	U/L	40--200
★ 血清乳酸脱氢酶	LDH	220	-	U/L	120-250
★ 血清α羟基丁酸脱氢酶	α-HBDH	173	-	U/L	72-182
★ 血清尿素	UR	7.10	-	mmol/L	2.6-7.5
★ 血清肌酐	CR	72.4	-	μmol/L	41-73
★ 血清尿酸	UA	287	-	μmol/L	155-357

注: 本检测结果仅对来样负责, 供临床参考。如有疑问请在样品保存期内提出!

检验者: 高平燕

审核者: 张若

带★项目为京津冀鲁互认项目

【胃功能检测】

检测机构: 慈铭健康体检管理集团有限公司 样本类型: 血清 样本性状: 样本正常
司北京奥亚医院
采集时间: 2026-03-01 08:25:03 检测时间: 2026-03-01 13:42:04 报告时间: 2026-03-01 16:13:11
【备注: 无】

项目	简称	结果	提示	单位	参考区间
胃泌素17	G-17	7.17	↑	pmol/L	1-7
★ 胃蛋白酶原I	PG I	184.99	↑	ug/L	70-165
★ 胃蛋白酶原II	PG II	23.71	↑	ug/L	3-11
★ 胃蛋白酶原比值(计算值)	PG I/PG II	7.80	-	-	7-20

注：本检测结果仅对来样负责，供临床参考。如有疑问请在样品保存期内提出！

检验者：张二斌

审核者：于娟

带★项目为京津冀鲁互认项目

【甲状腺功能检测】			
检测机构: 慈铭健康体检管理集团有限公司北京奥亚医院		样本类型: 血清	样本性状: 样本正常
采集时间: 2026-03-01 08:25:03	检测时间: 2026-03-01 13:29:54		报告时间: 2026-03-01 14:59:52
【备注: 无】			

项目	简称	结果	提示	单位	参考区间
★ 血清促甲状腺激素	TSH	0.862	-	mIU/L	0.56-5.91
★ 血清甲状腺素	T4	107.31	-	nmol/L	69.71-163.95
★ 血清三碘甲状原氨酸	T3	0.95	-	nmol/L	0.92-2.38

注：本检测结果仅对来样负责，供临床参考。如有疑问请在样品保存期内提出！

检验者：高平燕

审核者：张若

带★项目为京津冀鲁互认项目

【糖尿病检测】			
检测机构: 慈铭健康体检管理集团有限公司北京奥亚医院		样本类型: 血清	样本性状: 样本正常
采集时间: 2026-03-01 08:25:03		检测时间: 2026-03-01 13:26:50	报告时间: 2026-03-01 14:16:11
【备注: 无】			

项目	简称	结果	提示	单位	参考区间
★ 空腹血糖	GLU-0h	4.65	-	mmol/L	3.9--6.1

注：本检测结果仅对来样负责，供临床参考。如有疑问请在样品保存期内提出！

检验者：高平燕

审核者：张若

带★项目为京津冀鲁互认项目

【HPV检测】					
检测机构: 慈铭健康体检管理集团有限公			样本类型: 脱落细胞	样本性状: 样本正常	
司北京奥亚医院					
采集时间: 2026-03-01 08:32:14		检测时间: 2026-03-01 13:26:35		报告时间: 2026-03-03 10:37:28	
【备注: 无】					

项目	简称	结果	提示	单位	参考区间
★ HPV 18(高危型)	HPV 18	阴性	-	-	阴性
★ HPV 58(高危型)	HPV 58	阴性	-	-	阴性
★ HPV 59(高危型)	HPV 59	阴性	-	-	阴性
★ HPV 68(高危型)	HPV 68	阴性	-	-	阴性
★ HPV 6(低危型)	HPV 6	阴性	-	-	阴性
★ HPV 11(低危型)	HPV 11	阴性	-	-	阴性
★ HPV 26(高危型)	HPV 26	阴性	-	-	阴性

★ HPV 55(低危型)	HPV 55	阴性	-	-	阴性
★ HPV 66(高危型)	HPV 66	阴性	-	-	阴性
★ HPV 82(高危型)	HPV 82	阴性	-	-	阴性
★ HPV 83(低危型)	HPV 83	阴性	-	-	阴性
★ HPV 31(高危型)	HPV 31	阴性	-	-	阴性
★ HPV 40(低危型)	HPV 40	阴性	-	-	阴性
★ HPV 42(低危型)	HPV 42	阴性	-	-	阴性
★ HPV 43(低危型)	HPV 43	阴性	-	-	阴性
★ HPV 61(低危型)	HPV 61	阴性	-	-	阴性
★ HPV 44(低危型)	HPV 44	阴性	-	-	阴性
★ HPV 53(高危型)	HPV 53	阴性	-	-	阴性
★ HPV 81(低危型)	HPV 81	阴性	-	-	阴性
★ HPV 33(高危型)	HPV 33	阴性	-	-	阴性
★ HPV 16(高危型)	HPV 16	阴性	-	-	阴性
★ HPV 35(高危型)	HPV 35	阴性	-	-	阴性
★ HPV 39(高危型)	HPV 39	阴性	-	-	阴性
★ HPV 45(高危型)	HPV 45	阴性	-	-	阴性
★ HPV 51(高危型)	HPV 51	阴性	-	-	阴性
★ HPV 52(高危型)	HPV 52	阴性	-	-	阴性
★ HPV 56(高危型)	HPV 56	阴性	-	-	阴性

注：本检测结果仅对来样负责，供临床参考。如有疑问请在样品保存期内提出！

检验者：王艳红

审核者：许宏伟

【TCT检测】	检测机构: 慈铭健康体检管理集团有限公		样本类型: 分泌物	样本性状: 样本正常	
	司北京奥亚医院				
	采集时间: 2026-03-01 08:32:14		检测时间: 2026-03-03 08:29:41	报告时间: 2026-03-03 16:26:04	
	【备注: 无】				

项目	简称	结果	提示	单位	参考区间
液基薄层细胞学	TCT	无上皮内病变或恶性病变。建议每年做一次宫颈液基细胞学检查。	-	-	-

注：本检测结果仅对来样负责，供临床参考。如有疑问请在样品保存期内提出！

检验者：张景华

审核者：于淑婧

带★项目为京津冀鲁互认项目

【尿素呼气试验】			
检测机构: 慈铭健康体检管理集团有限公司北京奥亚医院		样本类型: 呼气	样本性状: 样本正常
采集时间: 2026-03-01 08:37:43	检测时间: 2026-03-01 14:20:36		报告时间: 2026-03-01 18:38:52
【备注: 无】			

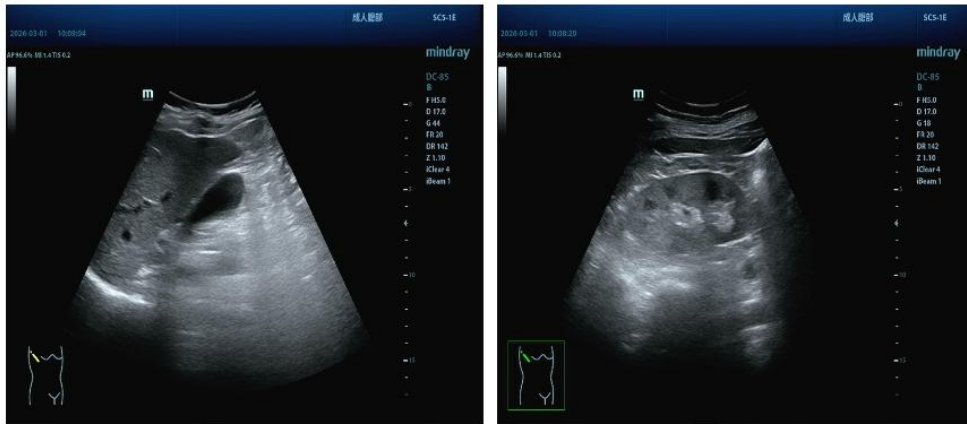
项目	简称	结果	提示	单位	参考区间
★ 碳14尿素呼气试验	C14	0	-	dpm	0-100

注: 本检测结果仅对来样负责, 供临床参考。 检验者: 王艳红 审核医师: 景琰

慈铭健康体检管理集团有限公司北京亮马桥医院 超声检查报告单

姓名：揭桂连 性别：女 年龄：56岁
体检号：71055732653897 检查时间：2026-03-01 10:06 报告时间：2026-03-01 10:10
检查项目：肝胆脾胰双肾彩超

关键影像：



超声所见：

肝脏彩超：
肝脏形态大小正常，轮廓规整，实质回声均匀，肝内管道结构清晰。门静脉未见扩张。
胆囊彩超：
胆囊形态大小正常，壁光滑，内未见明显异常回声。胆总管不扩张。
脾脏彩超：
脾脏形态正常，包膜光整，实质回声均匀。
胰腺彩超：
胰腺形态大小正常，轮廓规整，实质回声均匀，主胰管不扩张。
双肾彩超：
双肾形态大小正常，包膜光整，实质回声均匀。集合系统未见分离。

超声意见：

肝脏声像图未见明显异常
胆囊声像图未见明显异常
脾脏声像图未见明显异常
胰腺声像图未见明显异常
双肾声像图未见明显异常

诊断医生：邢心华

打印日期：2026-03-01

此报告仅对上述检查项目提供诊断信息，仅供诊断参考，不作其他用途

慈铭健康体检管理集团有限公司北京亮马桥医院 超声检查报告单

姓名：揭桂连 性别：女 年龄：56岁
体检号：71055732653897 检查时间：2026-03-01 09:59 报告时间：2026-03-01 10:00
检查项目：甲状腺彩超

关键影像：



超声所见：

甲状腺彩超：

甲状腺双叶及峡部形态大小正常，甲状腺右叶可见一个海绵样结节，大小约为14.9mm×13.5mm×7.3mm，边缘清楚，后方回声增强；CDFI：结节内未见明显血流信号。甲状腺左叶及峡部未见明显异常。

超声意见：

甲状腺右叶海绵样结节（TI-RADS 3类）

诊断医生：邢心华

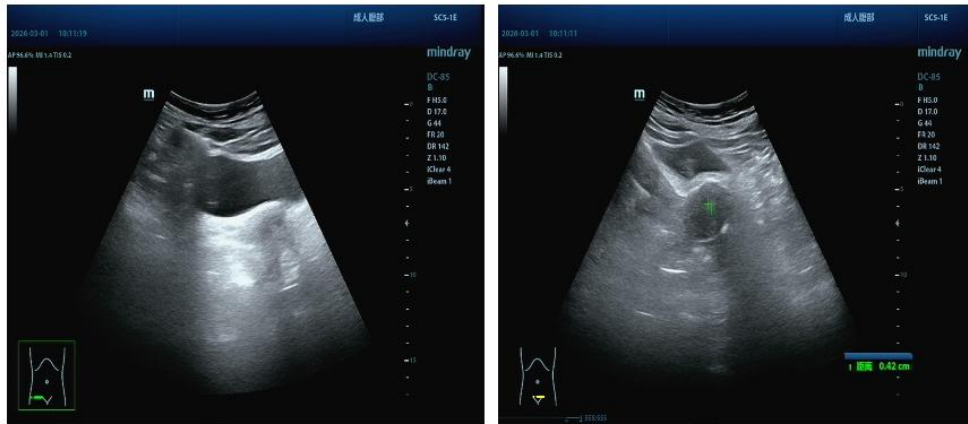
打印日期：2026-03-01

此报告仅对上述检查项目提供诊断信息，仅供诊断参考，不作其他用途

慈铭健康体检管理集团有限公司北京亮马桥医院 超声检查报告单

姓名：揭桂连 性别：女 年龄：56岁
体检号：71055732653897 检查时间：2026-03-01 10:08 报告时间：2026-03-01 10:09
检查项目：妇科彩超（经腹部）

关键影像：



超声所见：

子宫彩超(经腹部)：
子宫体积缩小，轮廓光整，肌层回声欠均匀，内膜厚约4.2mm，宫腔线居中。宫颈未见明显异常。
附件彩超(经腹部)：
双侧附件显示不清。

超声意见：

绝经期子宫
双侧附件显示不清

诊断医生： 邢志军

打印日期：2026-03-01

此报告仅对上述检查项目提供诊断信息，仅供诊断参考，不作其他用途

慈铭健康体检管理集团有限公司北京亮马桥医院 超声检查报告单

姓名：揭桂连

性别：女

年龄：56岁

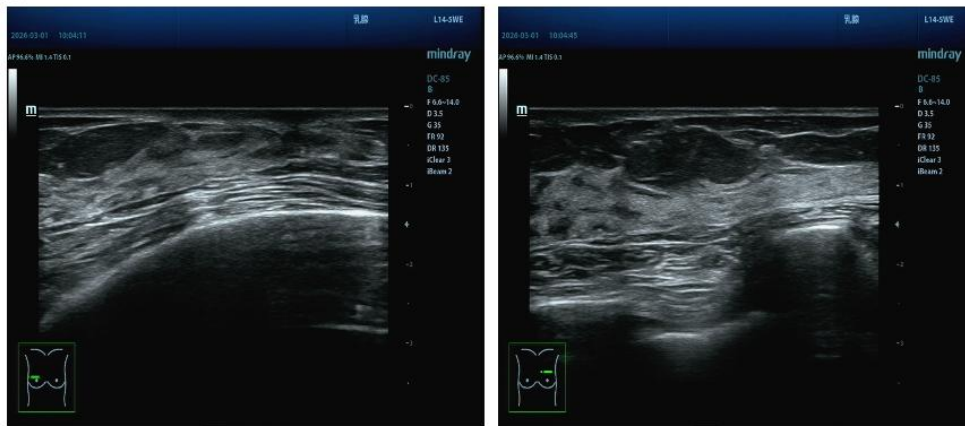
体检号：71055732653897

检查时间：2026-03-01 10:02

报告时间：2026-03-01 10:03

检查项目：乳腺超声

关键影像：



超声所见：

乳腺超声：

双侧乳腺腺体层次结构清晰，内部回声分布均匀，未见明显异常包块回声，CDFI：腺体内未见明显异常血流信号。

超声意见：

双侧乳腺未见明显异常

诊断医生：邢心华

打印日期：2026-03-01

此报告仅对上述检查项目提供诊断信息，仅供诊断参考，不作其他用途

慈铭健康体检管理集团有限公司北京亮马桥医院 超声检查报告单

姓名：揭桂连 性别：女 年龄：56岁
体检号：71055732653897 检查时间：2026-03-01 10:00 报告时间：2026-03-01 10:01
检查项目：颈动脉彩超

关键影像：



超声所见：

颈动脉彩超：

双侧颈总动脉、颈内动脉、颈外动脉管径对称，走行正常，内膜光滑，左侧内中膜不均匀增厚，较厚处约1.1mm，未见明显斑块回声，动脉管腔未见异常扩张或狭窄。PW：见双侧颈动脉血流速度及阻力指数在正常范围。

右侧颈总动脉管壁可见多个高回声斑块，大者约4.1mm×2.9mm；CDFI：斑块处血流充盈缺损；血流速度及频谱形态大致正常。

超声意见：

左侧颈总动脉内-中膜增厚

右侧颈总动脉斑块形成（多发）

诊断医生： 邢心华

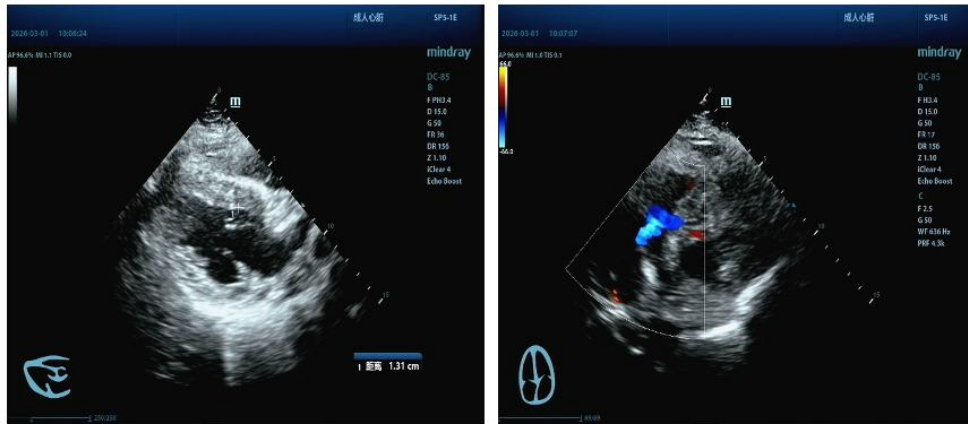
打印日期：2026-03-01

此报告仅对上述检查项目提供诊断信息，仅供诊断参考，不作其他用途

慈铭健康体检管理集团有限公司北京亮马桥医院 超声检查报告单

姓名：揭桂连 性别：女 年龄：56岁
体检号：71055732653897 检查时间：2026-03-01 10:03 报告时间：2026-03-01 10:05
检查项目：心脏彩超

关键影像：



超声所见：

心脏彩超：

1、各房室腔内径正常范围。主动脉及肺动脉内径及运动幅度正常。室间隔增厚，较厚处约13.1mm。左室壁厚度、运动幅度正常。房室间隔连续性完整。2、各瓣膜形态、启闭未见异常。CDFI：收缩期二尖瓣可见少量反流信号，收缩期三尖瓣可见少量反流信号，余各瓣口流速正常。3、心包结构正常。4、左室收缩功能参数正常。二尖瓣口前向血流：PW：E峰<A峰。TDI测得二尖瓣后瓣运动频谱e峰<a峰。心功能测值：EF：66% FS：34%

超声意见：

室间隔增厚
二尖瓣少量反流
三尖瓣少量反流
左室舒张功能减低

诊断医生：邢心华

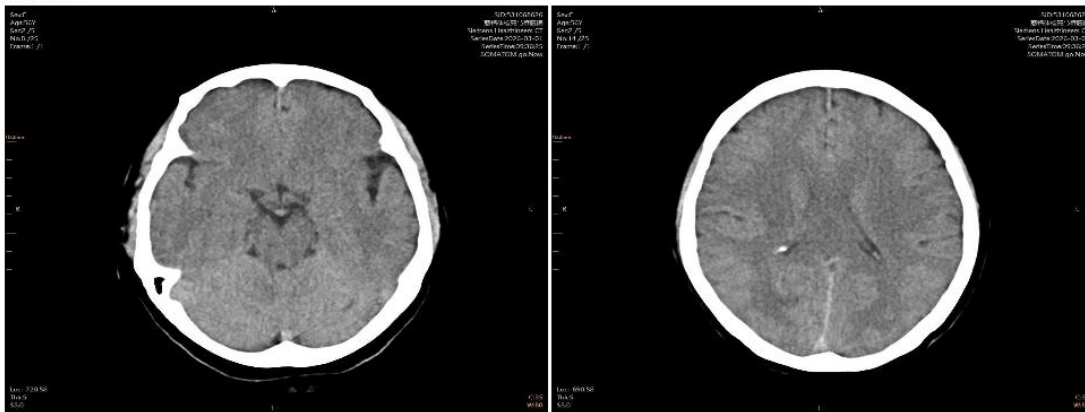
打印日期：2026-03-04

此报告仅对上述检查项目提供诊断信息，仅供诊断参考，不作其他用途

慈铭健康体检管理集团有限公司北京亮马桥医院 CT检查报告单

姓名：揭桂连 性别：女 年龄：56岁
放射学检查号码：p2603010037 体检号：71055732653897 检查时间：2026-03-01
检查项目：头颅CT平扫

关键影像：



放射学所见：

两侧脑实质内未见明显异常密度影及占位征象，诸脑室、脑池系统未见明显异常。诸脑沟未见明显异常扩大及变窄。中线结构居中。所示颅骨及软组织内未见明显异常。

放射学意见：（仅供临床医师参考）

头颅CT平扫未见明显异常

诊断医师：张新华 

审核医师：解维加 

书写报告时间：2026-03-01

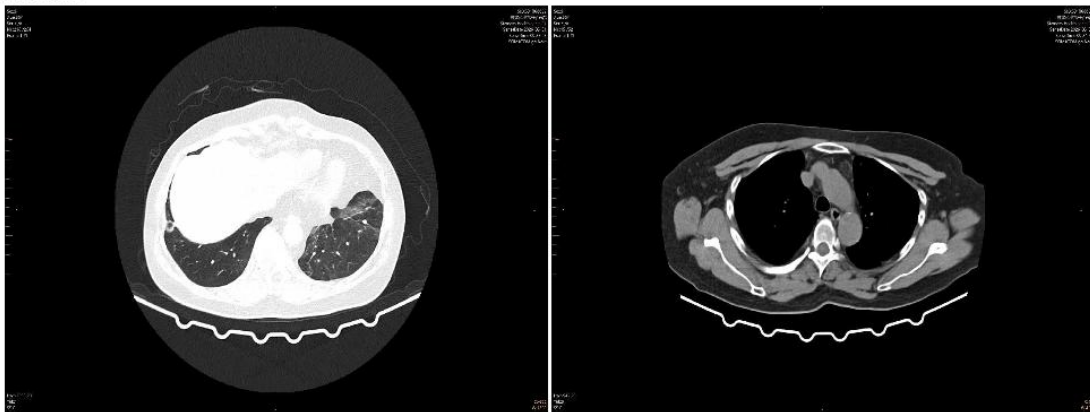
报告审核时间：2026-03-01

本报告非医疗诊断报告，任何医疗行为请遵从医嘱

慈铭健康体检管理集团有限公司北京亮马桥医院 CT检查报告单

姓名：揭桂连 性别：女 年龄：56岁
放射学检查号码：p2603010037 体检号：71055732653897 检查时间：2026-03-01
检查项目：胸部低剂量螺旋CT

关键影像：



放射学所见：

两侧胸廓对称；双侧肺门不大；心影及大血管形态正常。主动脉局部管壁可见钙化斑块影。纵隔未见肿大淋巴结。双肺野支气管血管束清晰，走行自然。左肺下叶见多发实性结节，较大者位于左肺下叶前内基底段（Se7：IM216），大小约为5mm×4mm。左肺下叶前内基底段（Se7：IM159）见钙化结节，大小约为3mm×2mm。双肺散在纤维条索影。

放射学意见：（仅供临床医师参考）

左肺实性结节灶，建议复查
左肺内钙化灶
肺内纤维灶
主动脉局部管壁钙化

诊断医师：张新华 

书写报告时间：2026-03-01

审核医师：解维加 

报告审核时间：2026-03-01

本报告非医疗诊断报告，任何医疗行为请遵从医嘱

慈铭健康体检管理集团有限公司北京亮马桥医院 DR检查报告单

姓名：揭桂连 性别：女 年龄：56岁
放射学检查号码：p2603010037 体检号：71055732653897 检查时间：2026-03-01

检查项目： 颈椎侧位DR(不出片)

关键影像：



放射学所见：

颈椎生理曲度存在，排列尚整齐，未见明显脱位征象。颈4-7椎体边缘可见骨质增生，椎体未见明显骨质破坏。颈4-7椎间隙变窄。前纵韧带钙化。

放射学意见：（仅供临床医师参考）

颈椎退行性改变

诊断医师：王豪杰

书写报告时间：2026-03-01

审核医师：李宇川

报告审核时间：2026-03-01

本报告非医疗诊断报告，任何医疗行为请遵从医嘱

北京华大医学检验所检验报告单

样本号：930200387

送检医院：慈铭健康体检管理集团有限公司北京亮马桥医院

姓名：揭桂连 病历号：71055732653897 送检时间：2026-03-01 15:36:56 诊断：
性别：女 申请科室：北京奥克兰新能源科 采样时间：2026-03-01 08:25:03 申请医生：
年龄：56岁 样本类型：血清 条码号：H0260301003101 备注：

序	代号	项目名称	结果	单位	参考范围
1	AFP	甲胎蛋白	7.04	ng/ml	<10
2	CEA	癌胚抗原	1.18	ng/ml	0--5
3	CA15-3	糖类抗原15-3	11.49	U/ml	0--25
4	CA125	糖类抗原125	23.57	U/ml	0--37
5	CA19-9	糖类抗原19-9	13.32	U/ml	0--35
6	EB VCA IgA	EB病毒VCA IgA抗体	0.15	S/Co	0--1

报告时间：2026-03-02 13:53:55 检验者：宋书宇 审核者：王新华

本检测仅对此样本负责，如果对结果有疑议，请于7日内与我们联系。

地址：北京市顺义区空港工业区B区（裕华路28号）6号楼2层 邮编：101300 电话：400-666-8705



慈铭健康体检管理集团有限公司北京奥亚医院

液基细胞学检测报告-妇科

送检单位：慈铭健康体检管理集团有限公司北京亮马桥医院

病理编号：GJ2026017298

姓名：揭桂连 性别：女 年龄：56岁 条码号：H0260301002009
电话： 门诊/住院号：71055732653897 科别： 病区/床号：
送检材料： 标本类型：分泌物 采样时间：2026-03-01
临床诊断： 送检医生： 送检时间：2026-03-01

镜下描述

样本满意度评估：☒ 满意 ☒ 颈管细胞 ☒ 化生细胞 ☐ 不满意（细胞量<10%）

鳞状上皮细胞病变或恶性病变

☒ 未见上皮内病变或恶性病变

微生物：☐ 阴道滴虫
☐ 真菌，形态上符合念珠菌属
☐ 菌群变化，提示细菌性阴道病
☐ 细菌，形态符合放线菌属
☐ 细胞变化符合单纯疱疹病毒感染

☐ 反应性细胞改变：☐ 炎症（包括典型修复）
☐ 萎缩
☐ 宫内节育器（IUD）
☐ 放疗
☐ 其他

☐ 非典型鳞状细胞：☐ 不能明确意义（ASC-US）
☐ 不排除高度鳞状上皮病变（ASC-H）

☐ 低度鳞状上皮内病变（LSIL） ☐ 提示HPV感染

☐ 高度鳞状上皮内病变（HSIL） ☐ 鳞状细胞癌

腺上皮细胞分析

☐ 非典型腺细胞（宫颈管）：☐ 非特异性改变
☐ 倾向于肿瘤性病变

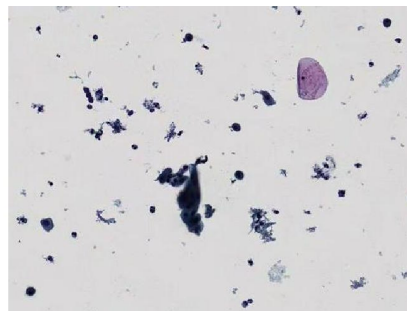
☐ 非典型腺细胞（宫内膜）：☐ 非特异性改变
☐ 倾向于肿瘤性病变

☐ 非典型腺细胞（来源不明）

☐ 腺癌：☐ 宫颈
☐ 宫内膜
☐ 其它

☐ 其他恶性肿瘤

镜见图示



病理诊断

无上皮内病变或恶性病变。建议每年做一次宫颈液基细胞学检查。

※本结果只对条码来样负责，如有疑问请在报告日期一周内提出。

第1页/共1页

报告医师：

张景华

审核医师：

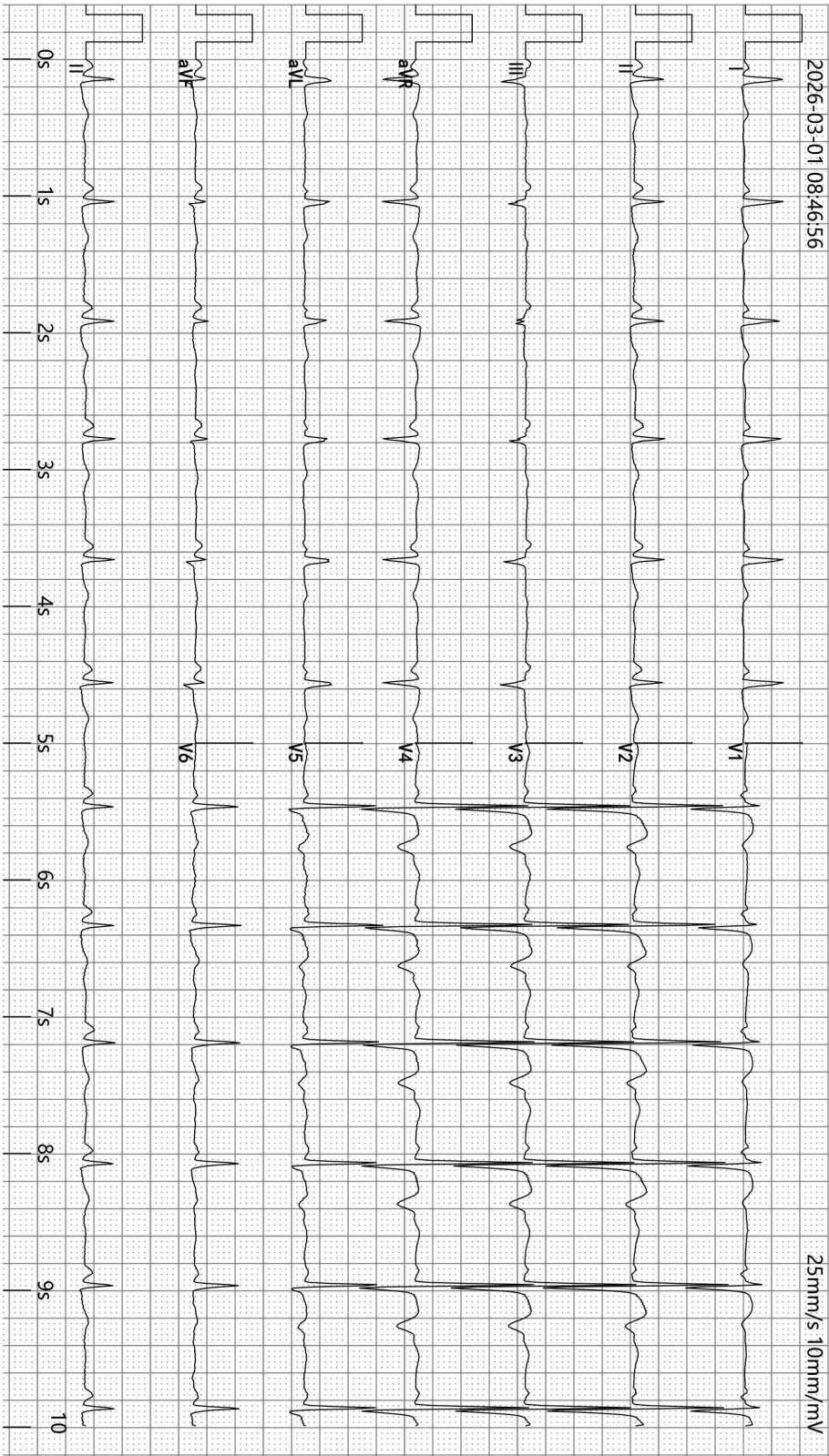
于淑娟

接收时间：2026-03-01

报告时间：2026-03-03

慈铭健康体检管理集团有限公司北京亮马桥医院 心电图报告

体检号: 71055732653897 心 率: 67bpm 诊断: 窦性心律
姓名: 揭桂连 SV1: -0.97mV 短P-R间期
性别: 女 RV5: 1.3mV QT/QTc: 387/411ms ST-T改变
年龄: 56岁 RV5+SV1: 2.27mV 电 轴: 1°



(本报告仅供临床医师结合临床参考, 不作诊断证明之用)

报告日期: 2026/3/1 8:56:24

检查者:

疏芳

诊断医生:

赵刚

I 温馨提示

尊敬的 揭桂连 女士

您好！

感谢您阅读我们给您呈上的健康体检报告！如果您对本次健康体检结果或健康体检报告存有任何疑问，或有相关事项需要咨询，请您前来或致电慈铭健康体检管理集团有限公司北京亮马桥医院客服部，电话：01084535277。

由于疾病的发生发展有其自身的客观规律，科学认知疾病需要渐进的过程，现有的医学技术存在局限性，加上您选择的健康体检套餐和项目限制，一次健康体检不可能发现所有疾病隐患和潜在的健康风险。如果您有任何不适，请及时就医。

为了您的健康，建议您每年进行一次全面健康体检，保持健康资料的完整性和连续性，以便于进行健康状况对照分析，提高健康管理的针对性和有效性。

祝您健康！

